



INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL

Programa de Atención Temprana



Amelia Barros Munita



Detrás de cada niño existe un potencial único.
Nuestra misión es **descubrirlo, comprenderlo**
y ayudarlo a **desarrollarse plenamente.**

Psicoeduka

Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil

📍 Santiago • 📍 Viña del Mar

www.psicoeduka.cl

I.- Antecedentes Personales.

Nombre : Amelia Barros Munita
R.U.T. : 27.580.392-8
Fecha de Nacimiento / edad : 21 de septiembre del 2021 / 4 años, 11 meses
Nivel escolar : No aplica
Establecimiento escolar : No aplica
Fecha evaluación : 07/07/26

II.- Motivo de consulta

Ingresó al programa PAT con el fin de potenciar la comunicación, AVD y autonomía para su contexto cotidiano.

III.- Anamnesis.

Antecedentes se encuentran en formato de Anamnesis como anexo al documento.

IV.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Sundberg, M. L. (2008). VB-MAPP: Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program.
- Prutting, C. A., & Kirchner, D. M. (1987). A clinical appraisal of the pragmatic aspects of language
- Protocolo de elaboración propia para evaluar habilidades lingüísticas y paralingüísticas.
- Matriz de la comunicación
- Cuestionario sensorial del hogar. SPM Sensory Processing Measure-preschool. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.
- Evaluación estructurada de integración sensorial
- Perfil Ocupacional inicial del niño (SCOPE) Registro Terapeuta Ocupacional/Reporte padres. The Modelo of Human Occupation Clearinghouse. Kielhofner.
- Edad de desarrollo para las actividades de la vida diaria. PORTAGE.
- Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Pardo M.
- Escala de juego preescolar de Susan Knox.

V. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.

Amelia se presenta con vestimenta y apariencia acorde a su edad e ingresa a la sala de forma autónoma. Se adecua positivamente al espacio explorando únicamente piscina de pelotas y columpio vestibular. En cuanto a la consigna de las actividades propuestas, no involucra al adulto y continua con el juego en solitario.



II. Valoración Cuantitativa.

Matriz de la comunicación

Nivel 1 Comportamiento preintencional	A1 Expresa incomodidad	A2 Expresa bienestar					A3 Expresa interés por otras personas															
Nivel 2 Conducta Intencional	B1 Protesta	B2 Continúa una acción		B3 Obtiene más de algo				B4 Llama la atención														
Nivel 3 Comunicación no convencional	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo						C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto									
Nivel 4 Comunicación Convencional	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo						C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas			
Nivel 5 Símbolos concretos	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombrar cosas o personas	C17 Hace comentarios					
Nivel 6 Símbolos abstractos	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombrar cosas o personas	C17 Hace comentarios					
Nivel 7 Lenguaje	C1 Rechaza o niega algo	C2 Pide más de una acción	C3 Pide una acción nueva	C4 Pide más de un objeto	C5 Elige	C6 Pide un objeto nuevo	C7 Pide objetos que están ausentes	C8 Pide atención	C9 C9. Muestra afecto	C10 Saluda a las personas	C11 Ofrece cosas o las comparte	C12 Dirija su atención a algo	C13 Usa fórmulas sociales con las que se manifiesta un trato amable	C14 Responde a preguntas de "Si" y "No"	C15 Hace preguntas	C16 Nombrar cosas o personas	C17 Hace comentarios					
	Rechaza	Obtener					Social					Información										

No se utilizan
 Emergente
 Dominado
 Superado

Cuestionario sensorial del hogar. SPM Sensory Processing Measure-preschool. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.

HOGAR

Comentarios: sin comentarios.

ÁREAS	DENTRO DE LOS RANGOS ESPERADOS (40T - 59T)	ALGUNOS PROBLEMAS (60T - 69T)	DISFUNCIÓN (70T - 80T)
VISIÓN			70
AUDICIÓN		63	
TACTO			77
CONCIENCIA CORPORAL			71
EQUILIBRIO Y MOVIMIENTO			79
PLANIFICACIÓN E IDEAS			75
PARTICIPACIÓN SOCIAL			75



Evaluación estructurada de integración sensorial.

Sistema Vestibular <i>Vías evaluadas: vestibulo-espinal lateral y medial/ conexiones vestibulo-cerebelosas</i>	Sistema Propioceptivo	Sistema Táctil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) (10 rotaciones en 20 segundos) Respuesta entregada: 10 1.- Extension anti gravitatoria y estabilidad articular proximal: Inconsistente, dificultad para la extensión de cuello y tronco. 2.-Reacciones de protección: Posiciona mano-muñeca. Inconsistente a nivel lateral y anterior en superficie blanda. 3.-Reacciones de equilibrio: 3.1 Reactivas: Inconsistente. 3.2 Anticipatorias: Inconsistente. 4.-Coordinación ocular: 4.1.-Seguimiento ocular: inconsistente. 4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza: Inconsistente, compensa con rigidez de cuello. 5.- Coordinación motora bilateral y letalidad: 5.1.- Coordinación bii: Inconsistente. 5.2.- Lateralidad: Inconsistente. 6.- Feedforward: Inconsistente. 7.- Respuesta al movimiento: Movimientos rotatorios: se intensifica el nivel de alerta. Movimientos lineales: logrado.	1.-Alineación de articulaciones: Inconsistente, compensa con aumento en la base de sustentación de EELL. 2.- Tono muscular: Dentro de rangos esperados. 3.-Control postural: Inconsistente. 4.- Planeamiento motor: Inconsistente, requiere de apoyo físico en actividades simples.	1.-Registro: 1.1.- Registra sin ver: inconsistente, requiere del estímulo. 1.2.-Se quita elementos sin ver: Inconsistente. 2.-Modulación: 2.1.-Copia 2D: no logrado. 2.2.-Copia 3D: no logrado. 2.3.-Copia con el cuerpo: -EE.SS: con apoyo físico inicial. -EE.II: Inconsistente. -Combinado: no logrado. 3.-Discriminación: 3.1.-Desafíos finos: desafíos para el entrenamiento de pinzas y agarres esperadas para su edad cronológica, compensa con agarre digital. 3.1.-Dificultades oro-faciales: No pesquisadas. 3.2.-Orden de su espacio: Inconsistente.



Perfil Ocupacional inicial del niño (SCOPE) Registro Terapeuta Ocupacional/Reporte padres. The Modelo of Human Occupation Clearinghouse. Kielhofnerf.

Área	Puntaje	Puntaje Total
Volición	3+4+3+1	11/16
Habitación	1+1+1+1	4/16
Habilidades de Comunicación e Interacción	3+3+1+1	8/16
Habilidades de Procesamiento	1+1+1+1	4/16
Habilidades Motoras	2+3+3+4	12/16
Ambiente	4+4+4+4+4	20/20
TOTAL		59/100

Edad de desarrollo para las actividades de la vida diaria. PORTAGE.

ACTIVIDAD	EDAD ACTUAL/APOYO
Alimentación	Apoyo verbal, no utiliza cubiertos, no utiliza vaso.
Vestuario	Apoyo multimodal, colabora en la postura de prendas.
Higiene	Apoyo multimodal, no controla esfínter, no tolera el lavado de dientes y cara debido a componentes sensoriomotores.
Autocuidado-Responsabilidad	Apoyo sustancial, desafíos para la mantención de hábitos.

Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Pardo M.

Dimensión	Puntaje bruto	Puntaje T	Categoría
Dimensión cognitiva	18	23	Retraso
Dimensión motricidad	20	23	Retraso
Dimensión lenguaje	6	23	Retraso
Dimensión socioemocional	19	23	Retraso
Escala total		23+23+23+23= 92:4=23	Retraso

Escala del juego preescolar de Susan Knox.

Dimensiones y factores	Edades en meses	Dimensiones y factores	Edades en meses
1 Manejo del espacio	18+6=24%2= 12 meses	3 Simulación/simbolismo	6+12= 18%2= 9 meses
1.1 Motricidad gruesa	18	3.1 Imitación	6
1.2 Interés	6	3.2 Dramatización	12
2 Manejo de materiales	12+12+6+6= 36%4=9 meses	4 Participación	6+6+12+12= 36%4= 9 meses
2.1 Manipulación	12	4.1 Tipo	6
2.3 Construcción	12	4.2 Cooperación	6
2.4 Propósito	6	4.3 Humor	12
2.5 Atención	6	4.4 Lenguaje	12
Edad del desarrollo del juego	12+9+9+9= 39%4= 10 meses		



III. Valoración Cualitativa.

1.- Desarrollo Psicomotor:

1.1.- Motricidad Gruesa:

A nivel de **control postural en bipedo**, Amelia logra desplazarse de forma independiente manteniendo una postura estable, guiando su cuerpo en función de la exploración del entorno.

A nivel de **control postural en sedente**, muestra control de cuello y tronco, al realizar actividades con mayor demanda cognitiva pierde el control postural, necesitando de un apoyo físico para lograr visualizar el material a utilizar.

A nivel de **planificación motora**, Amelia mediante la sistematización de nuevos patrones de movimiento logra replicar cuando el apoyo disminuye; permitiendo por ejemplo aplaudir al término de las actividades.

En relación con **actividades de feedback** (retroalimentación con otra persona) se observa que Amelia no logra realizar juegos con un balón orientándose al adulto para mayor interacción.

1.2.- Motricidad fina:

Amelia consolida el **agarre palmar y pinza digital**, lo cual permite manipular, transportar y sostener objetos durante las actividades de la vida diaria.

En relación con la **coordinación óculo manual**, Amelia logra observar antes de tomar objetos y para guardar objetos en diferentes espacios por cortos periodos de tiempo; se observan desafíos todavía a nivel de utilización de ambas manos donde se encuentran en proceso de entrenamiento para su uso funcional.

2.- Desarrollo Cognitivo:

Según lo entregado pautas de evaluación y observación clínica se pesquisa que Amelia presenta un retraso en el desarrollo de habilidades cognitivas básicas que le permitan complejizar la exploración e interacción con los contextos donde se desenvuelve, necesitando de un apoyo multimodal para mantener y lograr objetivos con mayor demanda. A continuación, se describen:

2.1.- Procesos básicos de atención/concentración:

Amelia logra mantenerse en el espacio y atenta al profesional que se encuentra junto a él entregando input vestibular. Con apoyo multimodal logra finalizar y mantenerse en tareas simples. Cabe resaltar que en actividades de interés y rutinas sensoriales simples logra focalizar de mejor forma su atención.



2.2.- Procesos básicos de secuenciación de tareas:

En actividades terapéuticas necesita de apoyo físico y verbal para lograr mantener y realizar secuencias de un criterio, cómo guardar todos los pompones de colores dentro de un contenedor. En actividades conocidas y realizadas de forma diaria logra secuenciar dos para un objetivo (sacar el individual e ir a la mesa para comer).

2.3.- Procesos básicos de discriminación, percepción y agudeza visual:

Se pesquisa que Amelia necesita una regulación del estímulo visual (elementos a utilizar) para lograr seguir la secuencia y realizar **procesos de discriminación** de diferentes elementos.

A **nivel de percepción y agudeza visuales** se observan desafíos que interfieren nuevamente con la prolijidad y consolidación de procesos ya mencionados.

Desde el área cognitiva, se buscará potenciar la interacción con el medio y la exploración de diferentes elementos, lo cual facilitará el proceso de consolidación de habilidades cognitivas básicas.

3.- Desarrollo Comunicación y Lenguaje

III.1 Etapa lingüística:

- III.1.1 **Exploración sistema estomatognático:** Amelia presenta mejillas de tamaño disminuido, con tono muscular de tipo hipotónico y buena funcionalidad. Los labios evidencian hipotonía leve; se mantienen ocluidos tanto en reposo como con esfuerzo voluntario, presentando adecuada forma y coloración. La lengua presenta una morfología en forma de corazón, se encuentra posicionada en el paladar y muestra adecuada coloración, aspecto y funcionalidad. Se observa dentición decidua completa, con todas las piezas dentarias visibles. En relación con el maxilar inferior, se evidencia un rango de movimiento adecuado, con correcta apertura bucal y movimientos laterales conservados. No fue posible evaluar la úvula ni el frenillo sublingual durante la valoración.
- III.1.2 **Funciones prearticulatorias:** Respecto al modo y tipo respiratorio, Amelia presenta respiración de tipo mixta-abdominal donde el aire ingresa por ambas vías (nasal - bucal) y se almacena en la cavidad abdominal. En cuanto a la realización de praxias bucofonatorias, Amelia logra la protrusión labial con disminución en la fuerza y presión, en el caso del soplo logra ejercer presión, sin embargo, no es suficiente en dosificación ni dirección. Finalmente, en la evaluación de la oclusión, esta se encuentra adecuada para cualquier consistencia.
- III.1.3 **Nivel de Forma:** Amelia presenta dificultades en la identificación de estímulos del lenguaje oral y de sonidos del entorno. No obstante, evidencia respuesta atencional frente a estímulos auditivos familiares, tales como la voz de su madre, la música de su programa favorito y sonidos producidos por objetos sonoros, como cascabeles y panderos.



Si bien logra localizar la fuente del estímulo auditivo, no demuestra capacidad para discriminarlo o diferenciarlo. En cuanto al nivel comprensivo, comprende algunos comandos funcionales de uso frecuente, tales como "bájate", "siéntate", "toma" y "más". Para comunicarse con el adulto y manifestar agrado o desagrado, utiliza emisiones de gorjeo con intención interactiva. Asimismo, en tareas de seguimiento de instrucciones, responde únicamente a dos órdenes básicas. Respecto a la comprensión de claves prosódicas, se observa reconocimiento de un patrón entonacional asociado a expresiones positivas, como "¡muy bien!", evidenciándose respuestas de gesticulación y sonrisas. Sin embargo, esta misma respuesta también se presenta frente a expresiones de tono negativo o cuando el adulto emite una orden, lo que sugiere dificultades para discriminar el contenido emocional de la entonación. En el ámbito expresivo, no se observan conductas de imitación vocal ni producciones verbales que se aproximen a palabras, con excepción de la emisión de "no", la cual aparece de forma descontextualizada y sin una intención comunicativa clara.

III.1.4 Nivel de Contenido: En relación con la atención hacia diferentes objetos, Amelia logra dirigir su atención a, al menos, tres estímulos distintos, observándolos en dos oportunidades durante la evaluación. Sin embargo, al presentarle los materiales correspondientes a la batería VB-MAPP, evidencia una marcada preferencia por una botella sensorial con agua y elementos brillantes, la cual manipula agitándola y observándola de manera sostenida durante aproximadamente cinco minutos. A pesar de la mediación del adulto y de la presentación de otros estímulos con el propósito de redirigir su atención, Amelia mantiene el foco de interés en dicho objeto. Respecto a la permanencia del objeto, no se observan respuestas consistentes frente a la desaparición de objetos; en contraste, manifiesta mayor interés cuando la desaparición involucra a personas, evidenciando una mejor respuesta ante este tipo de estímulos. Asimismo, se observa que Amelia presenta mayor atención hacia los adultos y sus pares que hacia los objetos del entorno. Responde a la mención de su nombre siempre que el adulto se encuentre próximo a ella, orientando la mirada o dirigiendo su atención hacia quien la llama.

III.1.5 Nivel de Uso: En relación con los patrones de mirada recíproca, estos se observaron en contexto clínico durante actividades altamente motivantes, utilizando piscina de pelotas, elementos visualmente llamativos y música de su preferencia. No obstante, cuando se le invita verbalmente a desplazarse hacia otro lugar o se menciona su nombre con dicho propósito, Amelia no dirige la mirada hacia el adulto. Asimismo, frente a la interrupción de una actividad de su interés, mantiene la mirada dirigida hacia el estímulo o el lugar donde este se encontraba durante un período prolongado, esperando que el adulto vuelva a ejecutar la acción que resultaba de su agrado.

En cuanto a la intención comunicativa, Amelia manifiesta conductas de rechazo, expresa agrado, desagrado, tristeza y felicidad mediante expresiones faciales y conductas no verbales. Además, utiliza emisiones de jerga como una forma de expresar necesidades o estados afectivos, aunque estas no constituyen producciones lingüísticas convencionales.



Respecto a otras habilidades, no se observan protoconversaciones durante la evaluación. Sin embargo, presenta sonrisa social, principalmente en contextos que resultan significativos para ella y que favorecen la interacción con el adulto. Finalmente, las habilidades de atención y acción conjuntas se evidencian únicamente en un contexto clínico estructurado, mediadas por el adulto y utilizando estímulos altamente motivadores para Amelia.

4.- Procesamiento sensorial y conducta

Según lo pesquisado en la evaluación SPM y en la observación clínica de integración sensorial, se establecen los siguientes desafíos a nivel de modulación sensorial en Amelia, los cuales se proyectan a través de la regulación conductual e interacción con el ambiente. A continuación, se describen patrones de conducta observados:

Sistemas sensoriales	Tipo de respuesta	Conducta Observada
Vestibular	Hiporespuesta, desafíos en la modulación de estímulos.	-Tiende a movilizar su cuerpo con movimientos oscilantes. -Dificultades en tiempos de AVD. -Desafíos para utilización de elementos diarios.
Propioceptivo	Hiporespuesta, desafíos en modulación.	-Sobre uso propioceptivo post actividades de mayor demanda y de forma ocasional durante estas. -Falta de prolijidad en los movimientos. -Participa en actividades donde debe empujar, saltar, arrastrar y levantar.
Auditivo	Hiporespuesta, desafíos de modulación de estímulos.	-Reacciona con molestia/incomodidad frente a sonidos sorpresivos y/o de mayor decibel. -Pareciera no seguir instrucciones a nivel grupal. -Produce sonidos fuertes para interactuar. -En ocasiones es como si no reconociera su nombre y/o instrucciones.
Táctil	Hiperrespuesta, desafíos en la modulación de estímulos.	-Presenta molestias ante el lavado de dientes, lavado de manos y lavado de cara. -No le gusta que la peinen/toquen el pelo. -No le gusta que le toquen las uñas. -Presenta desafíos sensoriales de alimentación. -Tiene una elevada tolerancia al dolor.

6.- Perfil ocupacional

6.1.- A nivel de volición: Amelia logra explorar el medio por medio de la observación, logra potenciar su desempeño e interacción con refuerzos sensoriomotores de movimientos lineales y rotatorios con apoyo del adulto, logrando potenciar su nivel de alerta y participación en lo que se encuentra realizando.

6.2.- A nivel de habituación: Amelia necesita de **apoyo multimodal** para lograr participar en tareas rutinarias, donde de forma ocasional espontáneamente reconoce y entrega una respuesta motora acorde a la demanda. A **nivel de actividades de la vida diaria**, se resiste el lavado de dientes, lavado de cara y manos con apoyo físico; en cuanto al vestuario/muda al entregar input sensorial propioceptivo logra colaborar con el adulto.



VI.- Síntesis / Diagnóstico

Desde el área de Terapia Ocupacional se observan **desafíos a nivel de interacción con el medio**, lo cual dificulta el entrenamiento y mantención de habilidades que le permitan el **desempeño funcional** en ocupaciones significativas **AVDB, JUEGO, EDUCACION, INTERACCIÓN SOCIAL**; necesitando de **estructuración** de espacios y **sistematización** de conductas adaptativas.

Considerando los elementos aportados por la familia, las observaciones realizadas por el equipo de fonoaudiología, los instrumentos aplicados, los criterios diagnósticos CATALISE, es posible señalar que Amelia presenta un **Trastorno del lenguaje (TL) asociado a Trastorno del Espectro Autista (TEA) con necesidad de apoyo comunicativo nivel 3**.

VII.- Sugerencias / Derivaciones

A la familia:

- Se sugiere la utilización de mochila con ruedas para la adquisición del hábito de pertenencias.
- Continuar con la comunicación directa con el equipo de trabajo PAT.
- Se sugiere estimular la atención y acción en juegos que impliquen relación directa con Amelia, como, por ejemplo: Burbujas, títeres, baile, cosquillas, etc.

Es todo cuanto podemos informar.



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA



Nicole Calderón
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 871683
GRUPO PSICOEDUKA



Catalina Barrios Villa
Fonoaudióloga Infanto-juvenil
GRUPO PSICOEDUKA

Santiago. Julio 2026

